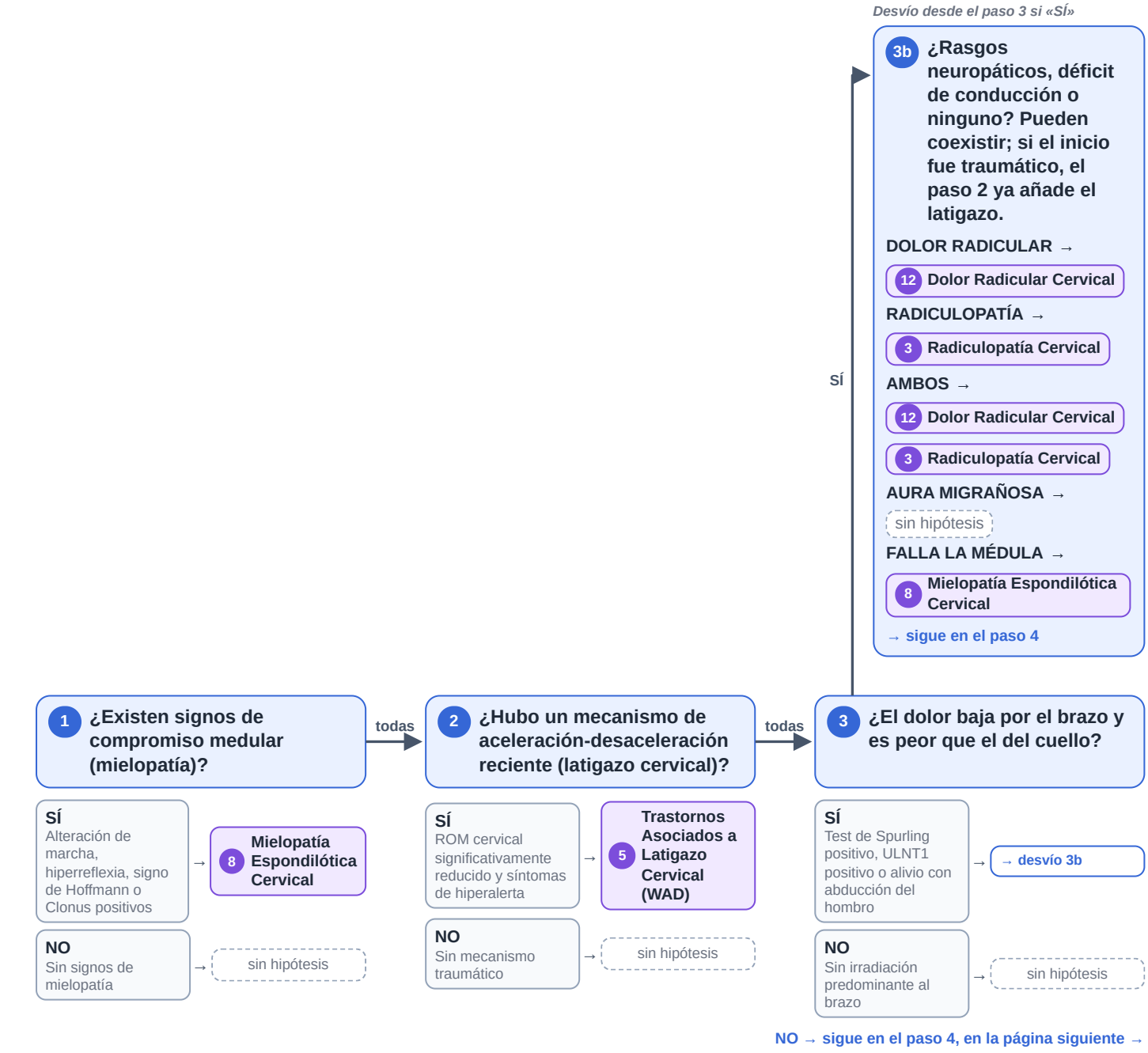
Algoritmo CIF — Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cervical. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 0739a9f6

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.



Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 4: viene del paso 3 o del 3b

4 ¿El síntoma principal es cefalea unilateral o dolor en base del cuello/hombro?

Cefalea unilateral
Test de Flexión-Rotación Cervical <30° y síntomas C1-C2
→ 4 Cefalea Cervicogénica

Cefalea primaria
Criterios de migraña o tensional (el cuello puede contribuir)
→ sin hipótesis

Dolor en hombro/escápula
Restricción de movilidad de 1ª costilla
→ 10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)

Dolor local/inespecífico
Sin cefalea ni irradiación dominante
→ sin hipótesis

todas →

4b ¿Hay mareo o inestabilidad como queja principal o acompañante? Descartar antes lo vascular (5 D y 3 N, disección).

MAREO CERVICOGÉNICO
Aturdimiento o inestabilidad ligados al cuello + error de reposición >4–5°
→ 13 Mareo Cervicogénico

VESTIBULAR
Vértigo rotatorio; tras golpe en cabeza o cuello, pensar también en conmoción
→ sin hipótesis

NO
Sin mareo
→ sin hipótesis

todas →

5 ¿Cuál es la función más alterada en este paciente?

Déficit de Movilidad
ROM activo reducido y PAIVMs C0-C3 hipomóviles
→ 1 Disfunción Articular Cervical

Déficit de Coordinación
CCFT alterado o test de reposicionamiento alterado
→ 2 Disfunción Neuromuscular Cervical

Déficit de Fuerza
Reducción de fuerza de flexión o extensión cervical
→ 6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular

Déficit de Resistencia
Fatiga muscular en actividades funcionales
→ 11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular

Déficit Postural
Lordosis reducida o cabeza adelantada evidente
→ 9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica

Dolor crónico inespecífico sin patrón dominante claro
→ 7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Dónde está la disfunción? En todos: tarea provocadora, postura, control motor y región torácica.

CRANEOCERVICAL (C1–2)
Dolor en los primeros grados de rotación, restricción precoz, FRT <30° o 10° de asimetría
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

FACETA CERVICAL
Extensión-rotación positiva + disfunción segmentaria palpable y dolorosa
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

CERVICAL BAJA Y CERVICOTORÁCICA
Giro libre al inicio pero excursión final limitada
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

NINGUNO
No es idiopático o no se localiza
→ sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0